

Перелом верхньої кінцівки

Сценарій

Ви лікар з медицини невідкладних станів. В складі бригади екстреної медичної допомоги ви прибуваєте на виклик до жінки 50 років з травмою правої верхньої кінцівки.

Скарги постраждалої: сильний біль в області нижньої третини передпліччя, деформація кінцівки, неможливість рухів в прменево-зап'ястковій ділянці.

Об'єктивно: В області ушкодженої верхньої кінцівки відмічається значний набряк м'яких тканин, при пальпації крепітація кісткових фрагментів та посилення болю, порушення функції кісті.

Необхідно: Провести огляд постраждалої, встановити попередній діагноз, визначити тактику надання невідкладної допомоги,

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнтом, встановлення контакту.	<i>Сказати</i> <i>Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я).</i>
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	<i>Сказати</i> <i>Ви даєте свою згоду на проведення обстеження та медичних маніпуляцій (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати</i> <i>Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Анамнез хвороби	<i>Сказати «Що з Вами трапилось»</i> <i>Очікуваний відповідь «Я йшла з кімнати в кухню та зачепилася за поріг втратила рівновагу та впала виставивши вперед руки відчула хрусткіт та різкий біль в нижній третині передпліччя, побачила деформацію передпліччя на протязі та появу набряку який збільшувався після цього викликала швидку»</i> <i>Сказати «Скільки часу менуло з моменту травми»</i> <i>Очікуваний відповідь «Приблизно 45 хвилин»</i> <i>Сказати «Чи втрачали ви свідомість»</i>

		<i>Очікуваний відповідь «Ні»</i> <i>Сказати «Чи намагалися ви самі собі допомогти»</i> <i>Очікуваний відповідь «Я спробувала поворухнути кінцівкою, але відчула сильний біль»</i> <i>Сказати «Ви сьогодні вживали алкогольні чи наркотичні засоби»</i> <i>Очікуваний відповідь «Ні»</i>
2.2	Скарги постраждалого	<i>Сказати: «Які у вас скарги?»</i> <i>Очікуваний відповідь: «Сильний біль в нижній третині передпліччя, деформацію передпліччя на протязі, набряк, посилення болю при рухах при рухах»</i>
2.3	Анамнез життя	<i>Сказати: «Чи страдаєте ви серцево-судинними захворюваннями»</i> <i>Очікуваний відповідь: «Ні»</i> <i>Сказати: «Які захворювання ви перенесли?»</i> <i>Очікувана відповідь: «ГРВЗ, дитячі інфекції.»</i>
2.4	Алергічний анамнез	<i>Сказати «Чи були у Вас алергійні прояви раніше і на що?»</i> <i>Очікувана відповідь: «Ні, не було»</i>
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	<i>Сказати: «Проводжу оцінку загального стану та життєво важливих функцій потерпілого: свідомості, дихання, кровообігу за алгоритмом ABCDE»</i> <i>Сказати: «Оцінюю рівень болю за шкалою ВАШ, також оцінюю АТ, пульс, ЧД»</i>
3.2	Візуальний огляд	<i>Сказати: «Проводжу огляд травмованого з голови до п'ятки з метою виявлення поєднаних пошкоджень, а саме:</i> -Наявність зовнішніх ознак травми - Визначення рухової активності великих суглобів. - Наявність деформацій скелету - Наявність підшкірної емфіземи та крепітацій»

		<i>Сказати:</i> «Колір шкірних покривів, вологість без змін, на правій верхній кінцівки на ділянці нижньої третини передпліччя виявляється наявність деформації. набряк м'яких тканин, при пальпації крепітація кісткових фрагментів та посилення болю, порушення функції кісті.
4. Діагностика		
4.1	Встановити попередній діагноз	<i>Сказати :</i> «Закритий перелом правої верхньої кінцівки в нижній третині передпліччя»
5.Алгоритм надання екстреної медичної допомоги		
5.1	Перший крок: Положення потерпілого.	<i>Сказати :</i> «Потерпілим з травмою необхідно обмежити фізичне навантаження, забезпечити повний психологічний спокій, обмежити потерпілого у самостійному пересуванні»
5.2	Другий крок: Забезпечення венозного доступу	<i>Виконати:</i> «Венозний доступ проводиться шляхом виконання стандартної процедури венозної пункції з дотриманням заходів асептики/антисептики катетером для внутрішньовенної пункції, який ретельно фіксується пов'язкою. Ввести 0,9% розчин натрію хлориду із розрахунку 20 мл/кг та 10% розчин гідроксиетилкрахмалю»
5.3	Третій крок: Транспортна іммобілізація	<i>Сказати:</i> «Транспортна іммобілізація стандартними та імпровізованими шинами, які накладаються по правилам, з фіксацією двох або трьох суміжних суглобів у всіх випадках переломів та вивихів кісток, а також при наявності великих ран, особливо в ділянці суглобів та підозрі на пошкодження крупних магістральних судин»

5.4	Четвертий крок: Усунення болю П'ятий крок: Госпіталізація	<i>Сказати:</i> «Для усунення болю необхідно введення ненаркотичних та наркотичних анальгетиків (кеторолак, кетальгін, реналган, дексалгін, трамадол, метамізол натрію, розчин декскетопрофену в/в повільно, однак перевага надається морфіну - вводити дробно по 2-5 мг кожні 5-15 хв до припинення больового синдрому або появи побічної дії (гіпотензії, пригнічення дихання, нудоти, блювання)» <i>Сказати:</i> «Всі потерпілі з травмою незалежно від статі, віку та інших факторів підлягають терміновій госпіталізації. Під час транспортування необхідно забезпечити моніторування стану потерпілого, проведення лікувальних заходів та готовність до проведення реанімаційних заходів. Транспортування здійснюється на ношах у відповідне відділення багатопрофільної лікарні або, оминаючи приймальне відділення, безпосередньо у операційне відділення, де проводиться екстрене оперативне втручання»
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	<i>Сказати :</i> В подальшому бути більш обачливими, уникати місць де можна отримати травму.
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	<i>Сказати-</i> Спокійний режим, уникнення фізичних навантажень, виконання рекомендацій лікарів в подальшому обстежені та лікуванні.